



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA KOMITE PENGENDALIAN
RESISTENSI ANTIMIKROBA
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3, Mondoroko, Singosari - Malang

Telp. 0341 - 458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



**PROGRAM KERJA KOMITE RESISTENSI ANTIMIKROBA
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) merupakan kepanitiaan di rumah sakit yang berperan dalam menetapkan kebijakan penggunaan antibiotik, pencegahan dan penyebaran bakteri yang resisten serta pengendalian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pada setiap kepanitiaan tersebut, apoteker berperan penting dalam meningkatkan penggunaan antibiotik yang bijak.

Penyakit infeksi di Indonesia masih termasuk dalam sepuluh penyakit terbanyak. Kejadian peresepan antibiotik yang tinggi dapat berpotensi untuk menimbulkan penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Penggunaan antibiotik dikatakan bijak apabila antibiotik digunakan sesuai antara penyebab infeksi dengan dosis optimal, lama pemberian optimal, efek samping minimal, dan dampak minimal terhadap munculnya mikroba resisten. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa telah muncul mikroba yang resisten antara lain *Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus* (MRSA), resistensi multi obat pada penyakit tuberkulosis (MDR-TB) dan lain sebagainya. Dampak resistensi bakteri terhadap antibiotik adalah meningkatnya morbiditas, mortalitas dan biaya kesehatan bagi pasien.

Di rumah sakit, penggunaan antibiotik yang tidak rasional mendorong berkembangnya resistensi terhadap bakteri yang akan menyebar melalui infeksi silang. Terdapat hubungan antara penggunaan atau kesalahan penggunaan antibiotik dengan timbulnya resistensi bakteri penyebab infeksi nosokomial. Resistensi tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diperlambat melalui penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional. Hal tersebut membutuhkan kebijakan dan program pengendalian antibiotik yang efektif.

Penggunaan antibiotik yang terkendali dapat mencegah munculnya resistensi antimikroba dan menghemat penggunaan antibiotik yang pada akhirnya akan mengurangi beban biaya perawatan pasien, mempersingkat lama perawatan, penghematan bagi rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Selain itu, penggunaan antibiotik yang tidak tepat oleh pasien meliputi ketidakpatuhan pada regimen terapi dan swamedikasi antibiotik dapat memicu terjadinya resistensi.

Muncul dan berkembangnya mikroba resisten dapat dikendalikan melalui dua kegiatan utama, yaitu penerapan penggunaan antibiotik secara bijak atau rasional (*prudent use of antibiotics*), dan penerapan prinsip pencegahan penyebaran mikroba resisten melalui kewaspadaan standar. Penggunaan antibiotik secara bijak ialah penggunaan antibiotik yang sesuai dengan penyebab infeksi dengan rejimen dosis optimal, lama pemberian optimal, efek samping minimal, dan dampak minimal terhadap munculnya mikroba resisten. Pengendalian penggunaan antibiotik dalam upaya mengatasi masalah resistensi antimikroba dilakukan dengan menetapkan Kebijakan Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit, serta menyusun dan menerapkan Panduan Penggunaan Antibiotik Profilaksis dan Terapi. Selain itu, untuk memastikan penggunaan antibiotik dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab, dapat dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus berdasarkan peraturan dan undang – undang yang berlaku, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406/ MENKES/ PER/ XII/ 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.



4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pedoman Penggunaan Antibiotik
5. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPM/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.
6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

1. Menggunakan antibiotik secara bijak dan rasional
2. Mencegah penyebaran mikroba resisten terhadap antibiotik

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang penggunaan antibiotik secara bijak dan rasional
2. Meningkatkan pelayanan farmasi klinik dalam memantau penggunaan antibiotik
3. Melaksanakan surveilans pola penggunaan antibiotik
4. Melaksanakan surveilans pola mikroba dan kepekaan antibiotik



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 Motto

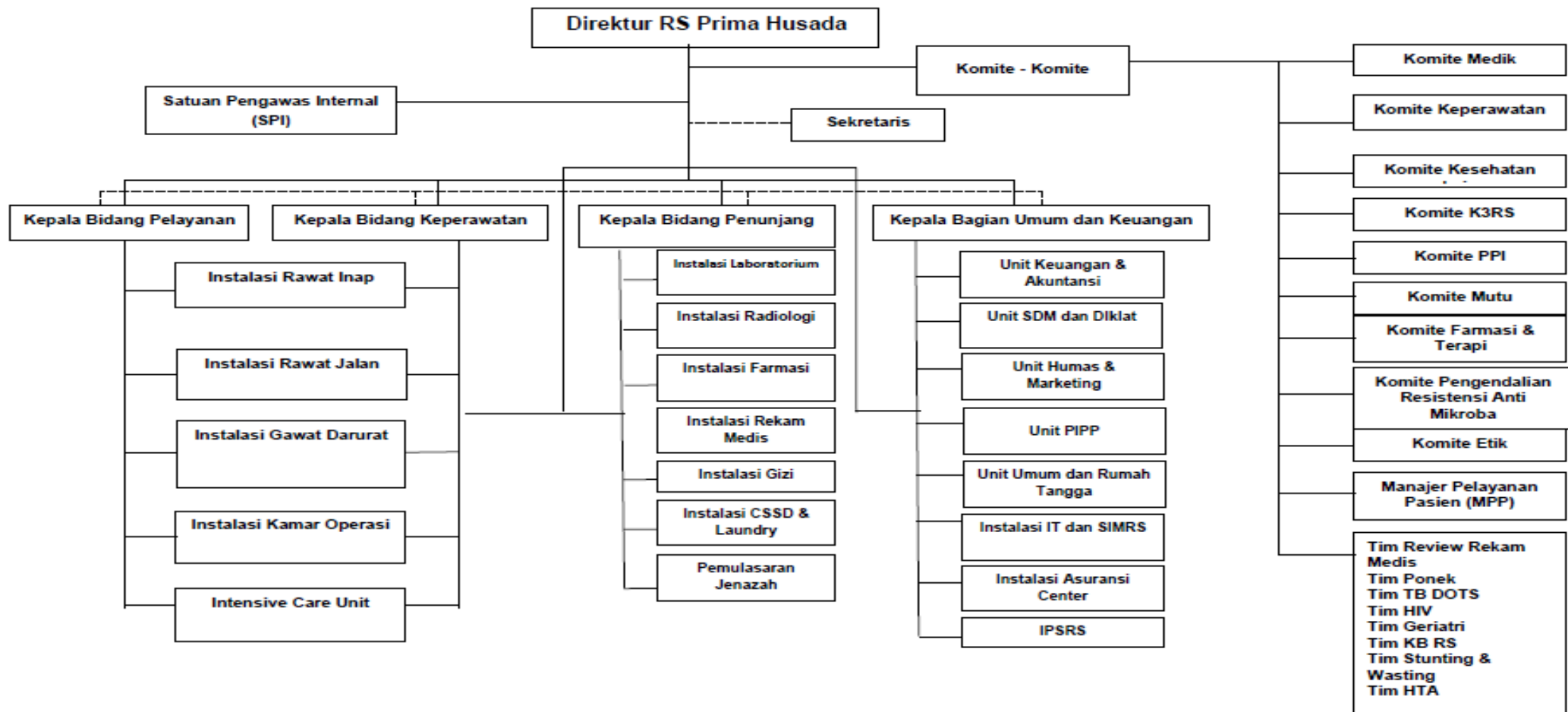
Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggungjawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT





SOTK KOMITE PPRA

Direktur RS. Prima Husada Malang

dr. Resti Lestantini, M.Kes



Ketua PPRA

dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed



Sekretaris PPRA

apt. Rildah Bunga Kwintana, S. Farm



Dokter Spesialis

1. dr. Ari Putriani, Sp.PK
2. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
3. dr. Ardhi Bustami, Sp.PD
4. dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD
5. dr. Antonius Setiadi, Sp. B
6. dr. Iwan Donosepoetro, Sp. B. FINACS
7. dr. Sigit WahyuJatmiko, Sp. BP-RE
8. dr. Heriyatmo, Sp. Pd
9. dr. Ira Setya, Sp. JP
10. dr. Dewi Maharani, Sp. S
11. dr. Titok, Sp. M
12. dr. Aida M., Sp. OG
13. dr. Andy, Sp. P
14. dr. Pradana Nurhadi, Sp. U
15. dr. Arianto, Sp. OT
16. dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ
17. drg. Bhakti Prasetyo D, Sp. Ort
18. dr. Nimim, Sp. KK

Dokter

1. dr. Naufal Farid Dwi Rendragraha
2. dr. Rino R.



Apoteker

1. apt. Yuanita Eka L, S. Farm
2. apt. Asharul Fahrizi, S.Farm
3. apt. Guspa Gayatri A, S.Farm
4. apt. Fadilah Maulana Irham A, S.Farm



Perawat

1. ns. Very Susanto, S. Kep
2. ns. Siti Durotul Ibadiah, S. Kep
3. Puput Sekar Nari Ratih, Amd. Kep
4. Sherly Rosita, Amd. Kep.
5. Trikaya Inggar Yuniar, Amd. Kep

2.6 Permasalahan Kinerja Tahun 2026

No	Program Kerja Tahun 2026	Hasil Pengembangan	Keterangan
1	Pembuatan Pola Kuman & Kepekaan Antimikroba	a. Pembuatan pola kuman yang dilakukan masih belum maksimal karena jumlah isolat yang digunakan masih terbilang sedikit yaitu sebanyak 107. b. Data isolat yang digunakan dalam pembuatan pola kuman diambil dari tahun 2023 dan 2024, yang seharusnya pengambilan data isolate diambil dari satu tahun sebelumnya	Belum berhasil karena kekurangan isolat
2	Pembaruan dan sosialisasi PPAB	a. Melakukan pembaruan PPAB yang telah ada dengan penyesuaian terhadap pola kuman terbaru serta mengacu pada PPAB Rumah Sakit percontohan b. Melakukan sosialisasi PPAB kepada dokter, dokter gigi dan dokter spesialis melalui: 1. Rapat PPRA 2. Rapat Komite Medik 3. Penyebaran PPAB pada poliklinik	Masih dalam proses penyusunan
3	Optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA	a. Pengajuan kepada tim IT untuk penambahan fitur permintaan antibiotik melalui <i>pop-up</i> pada SIMRS	Belum berjalan, masih dalam antrian pengerjaan programmer
4	Surveilans penggunaan antibiotik secara kuantitatif dan kualitatif	a. Pengumpulan data surveilans masih dilakukan secara manual dengan mengambil data pasien melalui ERM. Data yang diambil sebanyak 10 data setiap SMF yang selanjutnya dimasukkan ke <i>spreadsheet</i> pengumpulan data PPRA. Dengan metode manual tersebut, data yang di peroleh cukup terbatas. b. Penilaian kuantitatif dan kualitatif dilakukan oleh anggota PPRA, minimal 2 orang. c. Terdapat metode pelaporan eksternal melalui SIRS Online sehingga perlunya pemahaman terkait tata cara pelaporan dengan SIRS Online	Koordinasi dengan tim IT untuk dilakukan penambahan fitur laporan penggunaan antibiotik dengan format yang telah di ajukan
5	Surveilans resistensi antimikroba dengan indikator mikroba MDRO	Kurangnya permintaan kultur oleh DPJP	Belum berhasil karena kurangnya permintaan kultur



BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Pembaruan PPAB.	- Mengumpulkan data pola kepekaan bakteri di rumah sakit dengan menggunakan spesimen darah, urin, sputum, pus, maupun feses - Melakukan pembaruan PPAB yang telah ada dengan penyesuaian terhadap pola kuman terbaru dan berdasarkan Permenkes terbaru
2.	Peningkatan pemahaman terkait PPRA kepada seluruh tenaga kesehatan, staff rumah sakit, dan pasien / keluarga.	- Sosialisasi PPAB kepada dokter, dokter gigi dan dokter spesialis melalui: 1. Rapat PPRA 2. Rapat Komite Medik 3. Distribusi PPAB pada poliklinik - Sosialisasi penggunaan antibiotik secara bijak kepada tim medis Prima Husada Malang - Sosialisasi tentang penggunaan antibiotik yang bijak serta program kerja PPRA kepada staff farmasi RS Prima Husada Malang - Sosialisasi tentang penggunaan antibiotik yang bijak kepada pasien dan keluarga pasien (rawat inap dan rawat jalan)
3.	Optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA (Penatagunaan Antimikroba)	- Menerapkan sistem formularium antibiotik dan daftar antibiotik terbatas - Mewajibkan pengisian formulir PGA sebelum pemberian antibiotik kategori tertentu - Melakukan audit dan <i>feedback</i> berkala terkait pola persepsian antimikroba.
4.	Survailens penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif	- Melakukan pengumpulan data kuantitatif (DDD/100 <i>bed days</i>) dan kualitatif (audit ketepatan indikasi, dosis, durasi) - Menyusun laporan tren penggunaan antibiotik per bulan - Melakukan evaluasi kuantitatif dengan menggunakan metode ATC/DDD - Melakukan evaluasi kualitatif dengan metode Gyssens
5.	Survailens resistensi antimikroba dengan indikator mikroba MDRO	- Melakukan pemantauan terhadap kejadian infeksi oleh mikroorganisme resisten (MDRO), seperti ESBL dan MRSA. - Untuk laboratorium yang belum bisa mengidentifikasi ESBL/MRSA, tetap memantau MDR (resisten terhadap ≥ 3 golongan antibiotik). - Mengintegrasikan data resistensi dengan data klinis untuk mendukung pengambilan



		keputusan terapi.
6.	Peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi	- Menyelenggarakan forum kajian kasus terintegrasi (FORKKIT) secara rutin. - Melibatkan dokter klinis, apoteker, mikrobiologi, dan perawat dalam diskusi kasus. - Merumuskan perbaikan tata laksana infeksi dari hasil FORRKIT dan memasukkan ke dalam kebijakan rumah sakit

3.2 Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Pembentukan tim PPRA dan PGA	Membentuk tim PPRA dan PGA untuk melaksanakan program kerja	Tersedianya jumlah tenaga tim PPRA yang mencukupi	SDM	100%	SK anggota PPRA	
2	Sosialisasi PPRA kepada tenaga kesehatan	Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang PPRA	Staff tenaga kesehatan rumah sakit	Internal	100%	Umandok sosialisasi	
3	Sosialisasi penggunaan antibiotik kepada pasien dan keluarga	Meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga dalam penggunaan antibiotik secara bijak sebagai upaya pencegahan resistensi	Pasien dan keluarga pasien	Internal	100%	Dokumen sosialisasi	
4	Supervisi PPRA dan pelaporan PPRA internal dan eksternal	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penggunaan antibiotik	Tersedianya laporan PPRA	Internal	100%	LPD Laporan triwulan Laporan tahunan Bukti laporan eksternal	
5	Melakukan forum kajian kasus terintegrasi untuk kasus infeksi yang sulit (bila ada)	Mengkaji efektivitas antimikroba pada pasien yang mengalami perburukan kondisi klinis	Menyesuaikan	Internal		Umandok	

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Pembentukan Tim PPRA dan PGA	Pengajuan proposal	-	Proposal tim pembentukan PPRA	Januari 2026	SK Tim PPRA	
2	Sosialisasi PPRA kepada tenaga kesehatan	Sosialisasi kepada staff tiap unit rumah sakit	Daring / luring	1. Laptop 2. <i>Power point</i> 3. Jaringan Internet	Agustus 2026	Bukti dokumentasi sosialisasi kepada staff rumah sakit Prima Husada	
3	Sosialisasi penggunaan antibiotik kepada pasien dan keluarga	1. Sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien rawat jalan setiap bulan, bekerja sama dengan tim PKRS 2. Sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien rawat inap saat visitasi oleh apoteker rawat inap 3. Pemberian leaflet tentang antibiotik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan	Penyuluhan dan visitasi ke ruangan rawat inap	Leaflet penggunaan antibiotik bijak	Tiap bulan	Dokumentasi sosialisasi	
4	Sosialisasi panduan penggunaan antibiotik (PPAB)	Sosialisasi kepada DPJP terkait pembaharuan PPAB	Daring	1. Laptop 2. Jaringan internet	Februari 2026	Umandok	



				3. File PPAB terbaru			
5	Supervisi PPRA dan Surveilans penggunaan antibiotik secara kuantitatif dan kualitatif	1. Melakukan pengumpulan data berdasarkan LPD 2. Pelaksanaan permintaan antibiotik dengan melibatkan teknologi <i>pop up</i>	Elektronik	E-RM dan SIMRS	Januari 2026	1. laporan triwulan 2. Laporan tahunan 3. laporan eksternal melalui SIRS Online	
6	Surveilans pola mikroba dan antibiogram	Mengumpulkan dan melakukan analisis sampel untuk membentuk pola kuman dan antibiogram	-	-	Tiap tahun	Peta Kuman	

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
A.	Pengorganisasian																		
1.	Pembentukan Tim PPRA dan PGA	SDM Tim PPRA	√													RS Prima Husada	SDM		
2.	Penetapan penanggung jawab data di tiap tiap unit rawat inap	Tim PPRA	√													RS Prima Husada	SDM		
B.	Persiapan																		
1.	Review Pedoman Kerja PPRA	Tim PPRA		√												RS Prima Husada	SDM		
C.	Pelatihan																		



1.	Sosialisasi program kerja PPRA	Tim PPRA		√												RS Prima Husada	SDM		
2.	Sosialisasi Panduan Penggunaan Antibiotik	Tim PPRA		√	√											RS Prima Husada	SDM		
3.	Sosialisasi penggunaan antibiotik untuk pasien dan keluarga	Tim PPRA bekerjasama dengan tim PKRS Pasien dan keluarga pasien		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
D.	Fasilitas																		
1.	Ruang Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba	Tim Manajemen			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS Prima Husada		RS Prima Husada	
E.	Mutu dan Keselamatan Pasien																		
1.	Surveilans penggunaan antibiotik secara kuantitatif dan kualitatif	Tim PPRA		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS Prima Husada	Tim PPRA	RS Prima Husada	
2.	Penerapan penggunaan antibiotik berdasarkan panduan	Tim PPRA		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS Prima Husada	Tim PPRA	RS Prima Husada	
3.	Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotik	Tim PPRA						√						√		RS Prima Husada	Tim PPRA PPI	RS Prima Husada	
F.	Pelaporan																		
1.	Monitoring dan evaluasi penggunaan antibiotik tiap triwulan	Tim PPRA				√			√			√				RS Prima Husada	Tim PPRA	RS Prima Husada	
2.	Pelaporan ke KPRA Nasional (Laporan tahun sebelumnya)	Tim PPRA				√										RS Prima Husada	Tim PPRA	RS Prima Husada	

3.5 Kebutuhan Anggaran

Kebutuhan biaya pengembangan SDM Komite PPRA RS Prima Husada Malang Tahun 2026

No	Kegiatan / Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total Rp
1	Pembuatan pola kuman	Internal			Rp. 250.000.000,00
2	Pelaksanaan Sosialisasi staff rumah sakit terkait PPRA	Internal	212	-	-
3	Sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang : a. Penggunaan antibiotik secara bijak b. Peningkatan dan pemahaman resistensi antimikroba	Internal	-	-	-
4	Pelatihan pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit	Eksternal	1	4.500.000	4.500.000



BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Evaluasi program kerja komite PPRA dilakukan setiap satu bulan sekali dengan melihat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan pada bulan sebelumnya, sehingga apabila dari evaluasi terdapat ketidaksesuaian terhadap jadwal, maka dapat dilakukan perbaikan. Untuk menunjang kegiatan tersebut, perlu dilakukan pelaporan kepada Direktur Rumah Sakit setiap tiga bulan sekali.



BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan program kerja disampaikan berupa:

1. Laporan tiap 3 bulan
Sebagai laporan internal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit setiap 3 bulan.
2. Laporan Tahunan
Sebagai laporan internal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba kepada Direktur setiap tahun.
3. Laporan Tahunan
Sebagai laporan eksternal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba kepada Tim KPRA Pusat melalui SIRS Online (<https://perizinan-yankes.kemkes.go.id/sirsonline/>).



BAB VI
PENUTUP

Demikian Program Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit Prima Husada Malang tahun 2026 ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba Rumah Sakit Prima Husada Malang selama periode kerja tahun 2026. Kami menyadari dalam penyusunan program kerja ini masih banyak kekurangan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Mengetahui
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

Malang, 29 November 2025
Ketua Komite PPRA

dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed

